

УДК 618.146-006.6-615.37

А.Н.Баймахашева, В.И.Филиппенко, Ж.А.Тельгузиева, Ф.Т.Аюпов, А.А.Курманова, К.Х.Жапаев
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Иммунологическая эффективность вариантов комбинированной терапии больных раком шейки матки

Аннотация. В статье представлена иммунологическая эффективность различных вариантов комбинированной химиолучевой терапии при местно-распространенных формах рака шейки матки. Установлен прогноз клинического течения больных раком шейки матки и его связь с состоянием иммунореактивности

Ключевые слова: рак шейки матки, химиолучевая терапия, иммунологическая эффективность.

Рак шейки матки остается одной из наиболее распространенных опухолей женской половой сферы и занимает 3 место в структуре женской заболеваемости и 6 место в структуре основных форм злокачественных новообразований. Несмотря на то, что частота рака шейки матки на протяжении последних лет имеет некоторую тенденцию к снижению в Казахстане, анализ показателя уровня смертности от рака шейки матки остаётся высоким в странах СНГ и мире.

Цель настоящего исследования состояла в установлении взаимосвязи между состоянием иммунореактивности и ближайшим прогнозом клинического течения заболевания больных раком шейки матки (РШМ), до и на основных этапах комбинированной терапии.

Иммунологический мониторинг проводился 172 больным РШМ в динамике химиолучевой терапии (на фоне применения гемцитабина $n=56$, цисплатина $n=54$), 62 больным РШМ в динамике лучевой терапии (контрольная группа) и у 92 практически здоровых женщин. Определение клеточного иммунитета проводилось цитохимическим методом Мгудгудд в модификации (предпатент РК №13941) в динамике химиолучевой лучевой терапии с идентификацией 19 показателей, включающие определение лейкоцитов, абсолютного и относительного количеств лимфоцитов, Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, неТ-лимфоцитов нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов-макрофагов, иммунорегуляторного индекса Тх/Тс. Иммунологический мониторинг проводили во всех исследуемых группах согласно плана НИР до лечения, на этапе при СО^А (т.А, т.В) - 20 Гр и после завершения лечения, а также выполнялось контрольное обследование через 3 месяца после завершения терапии.

Проанализированы клинико-иммунологические показатели у

всех больных РШМ и у здоровых женщин. Идентификация основных показателей клеточного иммунитета у больных РШМ до лечения по сравнению со здоровыми показало наличие исходного Т-иммунодефицита, выражающегося в снижении абсолютного количества Т-лимфоцитов, Т-хелперов ($p<0,05$), при этом отмечается снижение показателя иммунорегуляторного индекса Т-х/Т-ло 1.25 ± 0.3 при норме 1.9-2.5. Также по сравнению с группой злопых лиц у больных раком шейки матки отмечается повышение уровня Т-супрессоров и незрелых лимфоидных клеток ($p<0,05$).

Идентификация основных показателей клеточного иммунитета больных раком шейки матки в двух исследуемых группах после завершения химиолучевого лечения показала некоторую стабилизацию иммунологических показателей, особенно в группе пациенток, получавших на фоне сочетанной лучевой терапии гемцитабин. В этой группе больных РШМ после окончания лечения наблюдалось увеличение абсолютного и относительного количества Т-лимфоцитов, Т-хелперов, тенденция к нормализации иммунорегуляторного индекса Тх/Тс, нейтрофилов, моноцитов-макрофагов ($p<0,05$), то есть показатели клеточного иммунитета приблизились к уровню «до лечения». В группе больных РШМ, получавших цисплатин на фоне сочетанного лучевого лечения (СЛТ) после завершения комбинированной терапии отмечается тенденция к улучшению основных показателей противоопухолевого иммунитета.

В контрольной группе больных РШМ, получавших сочетанную лучевую терапию по радикальной программе к

Таблица - Иммунологические показатели больных РШМ после завершения комбинированного лечения

Группы больных	К-во б-х	Т-лимфоциты	Т-хелперы	Т-супрессоры	Тх/Тс
Содержание показателей иммунореактивности приближается к уровню «до лечения» СЛТ+гемцитабин	34 (60,7 %)	66,2±2,0	38,5±2,1	32,7±1,6	1,3±0,3
Тенденция к снижению показателей иммунитета СЛТ+гемцитабин	22 (39,3 %)	59,6±1,7	32,4±1,8	30,5±1,7	1,1±0,3
Содержание показателей иммунореактивности приближается к уровню «до лечения» СЛТ+цисплатин	31 (57,4 %)	66,8±2,1	36,8±1,9	30,6±1,3	1,2±0,4
Тенденция к снижению показателей иммунитета СЛТ+цисплатин	23 (42,6%)	57,4±2,2	30,2±2,0	27,9±1,4	1,1±0,3
Все исследованные показатели снижены СЛТ	55 (88,7%)	56,5±1,5	30,4±2,0	28,4±2,0	0,9±0,1
СЛТ прервана до восстановления гематолог. показателей	7 (11,3%)	49,2±1,6	25,3±1,9	28,0±2,3	0,7±0,1

концу лечения отмечено достоверное снижение основных показателей клеточного иммунитета. Абсолютное количество Т-супрессоров в процессе сочетанной лучевой терапии значимо не менялось.

В таблице представлена иммунореактивность больных РШМ после завершения терапии.

Из данных таблицы видно, что у 34 (60,7 %) больных РШМ после СЛТ на фоне гемцитабина отмечены относительно высокие показатели иммунореактивности, близкие к уровню «до лечения». Прогноз клинического течения у этих больных относительно хороший и длительность безрецидивного периода составила 20 месяцев. У 22 (39,3%) больных РШМ после СЛТ на фоне гемцитабина была отмечена тенденция к снижению иммунореактивности и значения показателей были несколько ниже уровня «до лечения». Прогноз клинического течения можно считать относительно неплохим, длительность безрецидивного периода составила в среднем 16 месяцев.

У 31 (57,4%) больных РШМ после СЛТ на фоне цисплатина отмечены относительно высокие показатели клеточного иммунитета, близкие значения «до лечения». Прогноз клинического течения у этих больных относительно хороший и длительность безрецидивного периода составила 18 месяцев. У 23 (42,6%) больных РШМ наблюдалось некоторое снижение основных показателей противоопухолевого иммунитета после СЛТ на фоне цисплатина. Однако, прогноз клинического течения также можно считать «неплохим».

У 55 (88,7%) больных РШМ контрольной группы после СЛТ наблюдается достоверное снижение основных показателей клеточного иммунитета. Длительность безрецидивного периода у больных составила в среднем 10 месяцев. У 7 (11,3%) больных РШМ СЛТ была прервана вследствие лейкопении до восстановления гематологических показателей. Длительность безрецидивного периода составила в среднем 6 месяцев.

Во всех исследуемых группах у больных РШМ с полной регрессией опухоли отмечены более высокие показатели иммунореактивности к концу лечения, по сравнению с больными РШМ с частичной резорбцией опухоли.

Таким образом, установлено, что в группах больных раком шейки матки с относительно высокими показателями иммунореактивности наблюдается относительно хороший прогноз клинического течения и более высокая длительность безрецидивного периода. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности вариантов сочетанной лучевой терапии в сочетании с ме-

трономной химиотерапией у больных РШМ по сравнению со стандартной сочетанной лучевой терапией.

Список литературы

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ, - М., 2006. - Т. 17, №3.
2. Практическая онкология: избранные лекции. - СПб: Центр ТОММ, 2004. - 255с.
3. Muller J., Brun Del Re G., Burki H. Non-specific acid esterase activity: A criterion for differentiation of T- and B-lymphocytes in mouse lymph nodes//Eur. J. Immunol.-1975.-N5.-С. 270-274 (модификация предпатент РК #13941 получен 15.01.2004, бюл. №1).
4. Роуи А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология. - М.: Мир, 2000. - 582с.
5. Козаченко Н.В., Старикова С.Ю.. Проблемы диагностики иммунной недостаточности //Медицинская иммунология. - 2003. - Т.5, №3-4. - С.278.

Түжырым

А.Н.Баймахашиева, В.И.Филиппенко, Ж.А.Тельгузиева, Ф.Т.Аюпов, А.А.Курманова, К.Х. Жапаев

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Жатыр мойнының обыры бар науқастар комбинирланген терапияның иммунологиялық әсері.

Жатыр мойнының қатерлі ісігінді қолданылатын химиялық және сәулелік емдеу турақ тәсілдердің әдісіндегі иммундық, тиімділігі қорсетілген. Жатыр мойнының қатерлі ісігінің клиникалық ағымын прогноздау дененің иммундық реактивтілігіне байланысты екені анықталды.

Түйінді сөздер: жатыр мойнының обыры, химия-сәулелік терапия, иммунологиялық әсер.

Summary

A.N.Baymashasheva, V.I.Filippenko., Z.A.Telguzteva, F.T.Ayupov, A.A.Kurmanova, K.H. Zhapayev

Immunologically effective options combined therapy of patients with cervical cancer

In the article immunological effective using of different variants of the combine radiochemical therapy patients of cancer cervical are shown. It the shown prognosis of the clinical course of the cancer cervical patients in the connection with state immune.

Kywords: cervical cancer, chemo-radiation therapy, immunological efficacy.